

Estructura del sistema nacional de salud: MINSAL, SEREMI, Servicios de Salud y Atención Primaria de Salud (APS)

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El **Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS)** constituye la base organizativa del sistema sanitario chileno, estructurado para garantizar el **derecho a la protección de la salud**, consagrado en el **artículo 19 N°9 de la Constitución Política de Chile**.

Desde la reforma de salud del año 2005 (Ley N° 19.937), Chile cuenta con un modelo descentralizado y mixto, en el que el **Ministerio de Salud (MINSAL)** ejerce la conducción sanitaria nacional, y las **Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI)** y los **Servicios de Salud** ejecutan las políticas en los territorios.

El médico general —en especial en el contexto del **EUNACOM** y la práctica en **Atención Primaria de Salud (APS)**— debe comprender esta estructura para saber **dónde se toman las decisiones, cómo se implementan los programas y cuáles son sus competencias dentro de la red asistencial**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Sistema de salud: definición (OMS, OPS)

“El conjunto de organizaciones, instituciones, recursos y acciones cuyo objetivo principal es mejorar, mantener o restaurar la salud de la población.” (OMS, 2000)

Los sistemas de salud tienen tres funciones esenciales:

1. **Provisión de servicios.**
2. **Financiamiento y gestión de recursos.**
3. **Regulación y rectoría sanitaria.**

En Chile, el modelo es **mixto**, combinando un subsistema público (FONASA, Servicios de Salud, APS municipal) y uno privado (ISAPRES, clínicas privadas, seguros complementarios).

2.2. Marco legal

- **Ley N° 19.937 (2004):** Reforma a la Autoridad Sanitaria y descentralización del sistema.
 - **Ley N° 18.469:** Regula el ejercicio del derecho a la protección de la salud y crea FONASA.
 - **Ley N° 19.966:** Establece el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES/AUGE).
 - **Código Sanitario (DS 725):** Base legal para la organización sanitaria y funciones de la autoridad.
-

3. Estructura del Sistema Nacional de Salud (SNSS)

Chile cuenta con una **estructura sanitaria jerarquizada**, con tres niveles principales:

3.1. Ministerio de Salud (MINSAL) — Nivel Central

a) Rol general

El MINSAL es el **ente rector** del sistema de salud chileno, con funciones normativas, regulatorias y de conducción estratégica.

No presta atención directa, sino que **define políticas, normas y programas nacionales**.

b) Principales funciones

1. Formular políticas, planes y programas nacionales de salud.
2. Dictar normas técnicas y administrativas.
3. Regular, fiscalizar y coordinar las acciones del sistema público y privado.
4. Supervisar los organismos dependientes: FONASA, CENABAST, ISP, Superintendencia de Salud, etc.
5. Velar por el cumplimiento de las **Garantías Explícitas en Salud (GES)**.

c) Estructura interna

- **Subsecretaría de Salud Pública:** Rectoría sanitaria, vigilancia, promoción, prevención.

- **Subsecretaría de Redes Asistenciales:** Organización, gestión y control de la red asistencial pública.

d) Organismos dependientes del MINSAL

Organismo	Función principal
FONASA	Financiamiento del sistema público.
ISP (Instituto de Salud Pública)	Laboratorio nacional de referencia y control sanitario.
CENABAST	Abastecimiento y compra centralizada de medicamentos e insumos.
Superintendencia de Salud	Regulación y fiscalización de FONASA e ISAPRES.
SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML)	Apoyo pericial y forense en justicia y salud pública.

3.2. SEREMI de Salud — Nivel Regional

a) Definición

La **Secretaría Regional Ministerial (SEREMI)** es la **representación territorial del MINSAL** en cada región.

Su misión es ejercer la **autoridad sanitaria** regional, con funciones **normativas, fiscalizadoras y de vigilancia**.

b) Funciones principales

- Aplicar políticas, normas y programas del MINSAL en el territorio.
- Fiscalizar condiciones sanitarias y ambientales (alimentos, agua, residuos, establecimientos).
- Ejecutar acciones de **vigilancia epidemiológica y control de brotes**.

- Otorgar resoluciones sanitarias, autorizaciones y permisos.
- Promover intersectorialidad y participación ciudadana.

c) Rol del médico en SEREMI

Participar en:

- Investigación de brotes y notificación de enfermedades transmisibles.
- Fiscalización sanitaria en emergencias y desastres.
- Asesorías técnicas en vigilancia epidemiológica, zoonosis o salud ocupacional.

3.3. Servicios de Salud — Nivel Intermedio o Descentralizado

a) Definición

Los **Servicios de Salud** son organismos públicos descentralizados que administran la red asistencial de un territorio determinado.

Existen **29 Servicios de Salud** a lo largo del país (ej. Servicio de Salud Metropolitano Sur, Araucanía Norte, Aysén, etc.).

b) Funciones

- Planificar, coordinar y administrar los recursos humanos, físicos y financieros de los establecimientos.
- Ejecutar los programas ministeriales y GES.
- Supervisar hospitales, consultorios y postas rurales.
- Implementar las políticas de **Red Integrada de Servicios de Salud (RISS)**.

c) Establecimientos dependientes

- **Hospitales:** de baja, mediana y alta complejidad.
- **Centros de Salud Familiar (CESFAM).**
- **Consultorios urbanos y rurales.**

- **Postas de salud rural.**

3.4. Atención Primaria de Salud (APS) — Nivel Local

a) Definición

Es el **primer nivel de contacto** de la población con el sistema sanitario.

Su objetivo es resolver la mayoría de los problemas de salud de manera **integral, continua y familiar**, promoviendo participación y equidad.

b) Dependencia administrativa

- Gestionada por **municipalidades** (descentralización).
- Financiada principalmente por el **per cápita de FONASA** y aportes municipales.

c) Tipos de establecimientos

Tipo	Características principales
CESFAM	Atención integral y trabajo con enfoque familiar y comunitario.
CECOSF	Extensión comunitaria del CESFAM en zonas semiurbanas.
Posta Rural	Atención básica en zonas rurales, con Técnicos de Enfermería Nivel Superior (TENS) y rondas médicas.
SAPU / SAR	Servicios de atención primaria de urgencia, dependientes de la red APS.

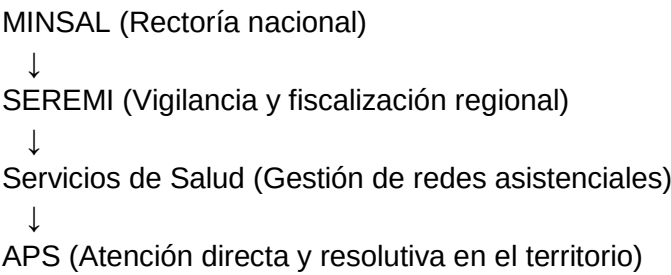
d) Principios del Modelo de Atención Integral en APS

- Enfoque familiar y comunitario.
- Continuidad del cuidado.

- Integralidad (biopsicosocial).
 - Intersectorialidad.
 - Promoción y prevención como ejes centrales.
-

4. Modelo de Red Asistencial

El sistema público chileno se organiza como una **red jerárquica y territorialmente integrada**:



La red busca asegurar **continuidad del cuidado**, con flujos de derivación **desde APS hacia niveles secundarios y terciarios** y retroalimentación permanente.

5. Financiación del sistema

Institución	Rol
FONASA	Recauda, gestiona y distribuye recursos del sistema público. Clasifica beneficiarios en tramos A–D según ingresos.
ISAPRE	Administran seguros privados de salud, financiados por cotización obligatoria del 7 % del salario.
MINSAL / Servicios de Salud	Asignan presupuestos, compran servicios y regulan el gasto sanitario.

El **80 % de la población chilena** se encuentra adscrita a FONASA, y el **20 % restante** al sistema privado (ISAPRE u otros).

6. Programas ministeriales relevantes

El MINSAL ejecuta políticas a través de **Programas Nacionales**, implementados por los Servicios de Salud y la APS:

Programa	Objetivo principal
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)	Cobertura universal de vacunas según edad y riesgo.
Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)	Control y prevención de enfermedades crónicas (HTA, DM2, dislipidemia).
Programa de Salud Infantil	Seguimiento del niño sano y control del desarrollo.
Programa de Salud de la Mujer	Tamizaje de cáncer cervicouterino, control prenatal, anticoncepción.
Programa de Salud Mental Integral	Atención comunitaria, prevención del suicidio, rehabilitación psicosocial.
Programa del Adulto Mayor	Envejecimiento saludable y prevención de dependencia.

7. Rol del médico general y competencias en APS

Según el **Perfil EUNACOM**, el médico general debe:

1. Comprender la estructura del sistema sanitario y su rol dentro de la red asistencial.

2. Participar activamente en la **implementación de programas ministeriales** y en la **coordinación con niveles superiores**.
 3. Notificar eventos sanitarios y coordinar acciones con SEREMI (brotes, epidemias, riesgos ambientales).
 4. Promover la participación comunitaria y la educación en salud.
 5. Asegurar la **continuidad del cuidado**, realizando derivaciones oportunas y contrarreferencias adecuadas.
 6. Evaluar el impacto local de políticas públicas y contribuir con indicadores de gestión sanitaria.
-

8. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Confundir funciones de SEREMI y Servicios de Salud	SEREMI → autoridad sanitaria y fiscalización; Servicio → gestión asistencial.
Creer que el MINSAL entrega atención directa	El MINSAL solo regula y coordina; la atención la realizan los Servicios y APS.
Pensar que APS depende directamente del MINSAL	Depende administrativamente de municipios y técnicamente de Servicios de Salud.
Olvidar la existencia de dos Subsecretarías (Salud Pública y Redes Asistenciales)	Ambas son esenciales para la gobernanza sanitaria.
Desconocer que el sistema chileno es mixto (público y privado)	80 % FONASA, 20 % ISAPRE.

Confundir funciones del médico APS con las del especialista

El médico APS actúa en promoción, prevención, tratamiento inicial y derivación.

9. Situación actual del sistema sanitario chileno

- **Cobertura pública:** 80 % (FONASA).
- **Gasto en salud:** 9,8 % del PIB (OCDE, 2022).
- **Desafíos actuales:**
 - Desigualdad territorial en acceso.
 - Listas de espera GES y no GES.
 - Envejecimiento poblacional y multimorbilidad.
 - Brechas en salud mental y ruralidad.

Política Nacional de Salud 2021–2030 (MINSAL):

Propone fortalecer la APS, la participación social y la equidad territorial, avanzando hacia un **Sistema Nacional de Salud Universal e Integrado**.

10. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El **MINSAL** es la autoridad sanitaria nacional: define políticas, normas y regula el sistema.
2. Las **SEREMI de Salud** ejecutan vigilancia y fiscalización sanitaria regional.
3. Los **Servicios de Salud** gestionan la red asistencial y los establecimientos dependientes.
4. La **APS** es la base del sistema público: promueve salud, previene enfermedad y resuelve la mayoría de los problemas sanitarios.
5. El sistema chileno es **mixto**, con mayoría de usuarios en **FONASA**.
6. El **médico general** es el eje del modelo integral de salud familiar y comunitaria.

7. El conocimiento de la estructura sanitaria es clave en el **EUNACOM** y en la práctica médica en Chile.